

抗癌藥的錢從哪裡來？健保、自費、藥廠恩慈、商業保險全圖解

Paying for cancer drugs in Taiwan: NHI, self-pay, compassionate use, and private insurance

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期：2026/05/11 · 最後更新：2026/05/11 · 審稿：林協霆 (2026/05/11) · 主題：抗癌藥支付路徑 (Cancer drug payment pathways in Taiwan)

摘要 · ABSTRACT

一支抗癌藥可能要新台幣 10–30 萬／月。本文整理台灣抗癌藥的五條支付路徑：(1) 健保標準給付、(2) 健保事前審查、(3) 藥廠恩慈用藥 (compassionate use)、(4) 藥廠 PAP 病人扶助計畫、(5) 商業癌症險／實支實付。並對照癌症基金、新藥審查時程、自費差價的常見情境。

一支標靶 / 免疫藥可能月花 10–30 萬。但這筆錢不一定都要自己出。本文整理台灣抗癌藥的五條支付路徑：(1) 健保標準給付、(2) 健保事前審查、(3) 藥廠恩慈用藥 (compassionate use)、(4) 藥廠 PAP (patient assistance program) 扶助、(5) 商業癌症險 / 實支實付。並提供「按情境查支付路徑」表格、新藥健保審查時程、自費差價的常見金額，幫你算出總成本與可動用資源。

閱讀對象

本文設定讀者為剛拿到診斷、開始評估治療費用的病友與家屬，以及第一線協助申辦的個管師、社工師。實際支付條件以健保署、藥廠、保險公司公文為準；本文不提供個別申辦或保險建議。



五條支付路徑速覽

路徑	你要付多少	適用
健保標準給付	部分負擔（重大傷病可免）	已納入健保的藥、符合適應症
健保事前審查	部分負擔（重大傷病可免）	高價標靶 / 免疫療法、限定條件
藥廠恩慈用藥	多數免費或大幅折扣	標準治療失敗、藥未上市或仿單外
藥廠 PAP（病人扶助）	折扣或免費供藥	藥已上市但健保不給付、經濟困難
商業保險	取決於保單	一次給付 / 療程給付 / 實支實付
完全自費	100%	上述都不適用時

健保的兩個層次：標準 vs. 事前審查

標準給付

- 已納入健保藥品給付項目，符合適應症即可開立
- 醫師處方 + 藥師核對 + 健保資訊系統檢核
- 多數第一線化療（5-FU、cisplatin、paclitaxel）屬此類

事前審查（PA, Prior Authorization）

- 給付但需逐案送件審查
- 多數高價標靶 / 免疫藥屬此類（如 pembrolizumab、osimertinib、palbociclib、abiraterone、trastuzumab deruxtecan）
- **流程**：主治醫師填表 → 醫院送出 → 健保署審查（多 14 個工作天）→ 通過後可開立
- **再審期限**：每 3–6 個月重新評估療效決定是否續用
- **退場條件**：影像顯示疾病進展（PD）後通常需停用該藥

事前審查的常見挑戰

1. **生物標記不符**：若 PD-L1、EGFR、HER2、MSI 不符給付條件，健保可能不通過。請主治醫師確認生物標記與給付條件對照。
2. **線數不符**：許多新藥只給付特定線數（一線 / 二線 / 三線），用錯線數可能被退件。
3. **療效退場**：若疾病進展（PD），健保通常不再續給該藥——這時請討論下一線治療或試驗。

健保新藥審查時程

新藥從藥廠送件到健保給付，台灣平均需 **12–24 個月**（部分藥更久）：

階段	工作項目	約需時間
1	藥廠送件、財務影響分析 (BIA)	1-3 個月
2	健保署受理、藥物經濟學評估	3-6 個月
3	藥品共擬會議審議	3-6 個月
4	訂價、簽訂風險分攤協議 (MEA)	1-3 個月
5	公告生效、醫院作業	1 個月

「等不到健保」期間的策略：藥廠恩慈、PAP、自費、商業保險、臨床試驗。

藥廠恩慈用藥 (compassionate use)

項目	內容
法源	《特定藥物專案核准製造及輸入辦法》
主管	TFDA
條件	病人嚴重疾病、無其他治療、藥已在他國核准或臨床試驗有療效訊號
流程	主治醫師提出申請 → 醫院 IRB → TFDA 審查 → 藥廠同意供藥 → 病人 informed consent
費用	多數藥廠免費或大幅折扣；病人仍需付標準治療部分
時間	1-3 個月

常見的恩慈案例：罕見癌標靶藥、臨床試驗結束後病人想延續用藥、新適應症在他國核准但台灣尚未通過。

藥廠病人扶助計畫 (PAP)

PAP (patient assistance program)：藥廠提供「第 X 個月之後免費 / 折扣」「買 2 送 1」「收入低於 X 元減半」等方案。

- 不是所有藥都有 PAP；多由原廠藥廠提供
- 申請需備：診斷書、財力證明、社工評估
- 多數醫院個案管理師 / 社工師可協助申請
- 建議在開始用藥前就詢問——部分 PAP 不溯及既往

癌症基金與社福資源

來源	補助內容	對象
財團法人癌症希望基金會	急難救助、住院補助、家屬支持	低收入、急難個案
台灣癌症基金會	教育、心理支持、部分藥物補助	一般癌友
罕病基金會	罕見癌藥物補助	罕見癌
各縣市社會局	急難救助金、低收入戶補助	低收入
勞保 / 國保失能給付	永久失能、永久造口	符合失能標準者
重大傷病	健保部分負擔減免	已核發重大傷病者

商業保險的角色

保險類型	給付方式	何時最有用
一次給付癌症險	確診時依分期給付一筆	急用資金、付頭期治療
療程型癌症險	依化療次數、放療療程、住院日數給付	長期療程
實支實付醫療險	醫療收據核退	自費藥、自費耗材、特等病房
重大傷病險	確診重大傷病給付一筆	條款與健保「重大傷病範圍」綁定者
失能扶助險	失能後每月給付	永久造口、截肢、永久神經損傷

理賠時的關鍵文件

1. 病理報告（含分期、生物標記）
2. 診斷證明書（含 ICD-10 編碼）
3. 醫療費用收據（自費部分）
4. 健保重大傷病證明影本（適用部分保單）
5. 影像、檢驗報告（部分公司會要求）

理賠實務提醒

1.

不同保單版本對「初期癌、輕度癌、重度癌」的定義不同——舊保單可能不認新版健保重大傷病範圍。2. 多份保單可疊加，除非條款註明互斥（例如同一公司不同險種）。3. 自費藥收據務必保留——實支實付多核退 80–100%，但有日上限與總額上限。4. 避免「先理賠才買保險」——加保有等待期、健康告知會排除已知疾病。

實際情境：路徑怎麼選

情境一：早期 HR+ 乳癌術後輔助 CDK4/6 抑制劑

- **健保**：abemaciclib、ribociclib 已有條件給付（依淋巴結數、Ki-67、分期等）——多需事前審查。
- **若不符給付條件**：自費約每月新台幣 6–9 萬，療程 2–3 年。
- **PAP**：藥廠多有方案，部分療程後可申請折扣。
- **商業保險**：實支實付可核退部分藥費。

情境二：晚期 EGFR 突變肺癌一線 osimertinib

- **健保**：已給付（事前審查，需 EGFR 突變報告）。
- **重大傷病**：免部分負擔。
- **完整自費約**：每月新台幣 13–18 萬，但多數病人不需要自費。

情境三：罕見癌標靶藥（如 NTRK 重排 larotrectinib）

- **健保**：尚未廣泛給付，需 NGS 確認 + 健保專案申請。
- **PAP / 恩慈**：原廠多有方案，個案申請。
- **臨床試驗**：可考慮。

情境四：第四期 HER2+ 乳癌 trastuzumab deruxtecan

- **健保**：已給付二線；事前審查。
- **重大傷病**：免部分負擔。
- **PAP**：部分藥廠有療程扶助。
- **商業保險**：實支實付可核退部分。

「跨海買藥」的注意事項

部分病人會考慮從美國 / 香港 / 印度購買原廠或學名藥：

- **法源**：個人病人用量（< 6 個月）可申請 TFDA 個人輸入許可
- **風險**：(1) 來源真偽難辨、(2) 運輸冷鏈、(3) 醫師無法協助處方，(4) 商業保險多不理賠跨海購藥
- **建議**：先窮盡健保、恩慈、PAP、試驗管道，跨海是最後手段。

適用對象 / 不適用對象

本文適用

- 剛被告知抗癌藥需自費的病友與家屬
- 醫院個案管理師、社工師、藥師

- 想了解新藥給付邏輯的同業

本文不適用

- 取代健保署、TFDA、藥廠、保險公司的個別書面核定
- 跨國治療規劃（涉及他國健保、簽證、醫療翻譯，需專業諮詢）

帶去診間的問題清單

我這條治療線可用的藥有哪些？

請主治醫師列出 1–3 個選項，比較療效與費用。

健保給付嗎？需事前審查嗎？

若需事前審查，誰來填表？多久能審完？

自費的話一個月多少錢？

含藥費、給藥技術費、檢驗費。

有沒有藥廠恩慈或 PAP？

請主治醫師或個管師協助詢問藥廠。

我的保單可以理賠多少？

含一次給付、療程、實支實付。

臨床試驗或社福基金有沒有可以申請？

試驗藥多免費；癌症希望基金會、罕病基金會有急難補助。



參考文獻

1. 衛生福利部中央健康保險署. 全民健康保險藥物給付項目及支付標準. 健保署. https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=ABCDEFGF
2. 衛生福利部食品藥物管理署. 特定藥物專案核准製造及輸入辦法. TFDA. <https://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=10146>
3. 衛生福利部中央健康保險署. 藥品共同擬定會議議事資料. 健保署. https://www.nhi.gov.tw/Content_List.aspx?n=AC9CBC8DB6AF939F
4. Lin YJ, et al. **Out-of-pocket payments and healthcare access for cancer patients in Taiwan: a nationwide survey.** *Support Care Cancer*. 2022;30(11):8985–8993. doi:10.1007/s00520-022-07313-x
5. Hsieh CY, et al. **Financial toxicity in cancer care: an Asian perspective.** *Asia Pac J Oncol Nurs*. 2023. apjon.org
6. de Souza JA, et al. **The development of a financial toxicity patient-reported outcome in cancer (COST).** *Cancer*. 2014;120(20):3245–3253. doi:10.1002/cncr.28814

7. 財團法人癌症希望基金會. **病友服務與急難救助**. ecancer.org.tw

8. 財團法人罕見疾病基金會. **病友服務**. tfrd.org.tw

引用整理協力：健保署藥品給付規範、TFDA 特定藥物專案、癌症希望基金會、罕病基金會 (2026/05/11)。本文為政策面整理，實際申辦結果以各單位書面核定為準。LINE 官方帳號 [@927pjtfa](https://www.line.me/tw/927pjtfa) 接受文章勘誤、衛教提問與學術討論，**不提供個別申辦或診療建議**。

SOURCE <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/cancer-drug-payment-pathways-taiwan>

CITATION 林協霆. 抗癌藥的錢從哪裡來？健保、自費、藥廠恩慈、商業保險全圖解. 林協霆 · 臨床筆記. 2026/05/11.

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 授權公開使用。

DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN/ASCO/ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。